



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هدي شحات احمد عبدربه
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : كرداسه
رقم البطاقة : 28202022102068 رقم التليفون : 01026758765
العنوان : كرداسه
العمر (تاريخ الميلاد) : 02-02-1982 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور
قسم العلاج :
الاورام

[14163]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هدي شحات احمد عيديره National ID: 28202022102068	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية العراق
مملكة تحالف العشائر

هادي
شحات احمد عديريه
١٢ قرية كرداسه
مركز كرداسه - الجيزه

٢٨٢.٢.٢٢١.٢.٦٨

١٩٨٢

KU0323097

٢٠٢٤/١١ ٢٨٢.٢.٢٢١.٢.٦٨

ربة منزل

أنثى
مسلمة
متزوجة

خالد حنفي محمد زكيو

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٠/١١

١



MDT Form

A- Patient ID:

1- Name: **میری شہناز احمد عطار**

Sex:

3- Medical number:
Female

83233704
Old Med:

3263-2024

2- ID number:

Patient Age: 43 Y



Family history

Phone

01026756765

6M1

REASON OF HDT

Marital status

NRS Score

GROUP

Date of HDT

09/12/2024

Co-morbidity

Menopausal status

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging:

1. Breast: suspicious solid mass lesion, pathological LNs

Mets Workup:
cap:free

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

Ki67

ILIC

8/8

8/8

2

Not Amplified

10

1

N

M

D

Sonomammography

PATIENT HISTORY

RT BCS+S;NB: free all margins
7/71 extra capsular extension

MDT OUTCOME & PLAN

FOR ADJUVANT 4 X AC TAXOTERE X4
PORT
AI + ZOLADEX
ZOMETA /6M AFTER DENTAL ASSESSMENT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

NEERAJ DADGAR

RADIOLOGY

SURGERY

SURGEY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatrist

Nutrition



Patient Name : الأستاذة / هدى شحات أحمد عبدريه	Request No. : 13009201
Patient No. : 28202022102068	Request Date : 16/10/2024
Path No. : 3968/24	Verification Date : 02/11/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 42 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data :

Right breast mass.

Nature of specimen:

Right breast conservative surgery and axillary lymph node dissection specimens collected at 16/10/2024.

Gross examination:

Two specimens were received:

1) Sector of mammary tissue 12x8x3 cm with no covering skin ellipse, serial cuts revealed ill defined rubbery to firm mass measured 1.8x1.7x1.5 cm, located 0.1 cm from least superior margin, 0.2 cm from inferior margin, 0.5 cm from superficial margin, 1.5 cm from medial margin, 3 cm from lateral margin and 3.5 cm from deep margin. Breast tissue showed attached 5 nodules measured up to 1.5x1x0.8 cm.

2) Axillary lymph node dissection specimen: A separate fibrofatty tissue pieces collectively 10x7x2 cm entangling 16 nodules up to 2.5x2x1 cm

-Frozen section :

-Free margins.

Microscopic examination: :

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): G II (3+2+1).
- Lymphovascular invasion: Positive.
- Ductal carcinoma in situ: Not detected.
- Lymph node involvement: Positive (7/21) with extracapsular extension.
- Resection Margins: Free all resected margins
- Additional pathologic findings: Microcalcifications.

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 03/11/2024 09:57:27

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / هدى شحات أحمد عنبريه	Request No. : 13009201
Patient No. : 28202022102068	Request Date : 16/10/2024
Path No. : 3968/24	Verification Date : 02/11/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 42 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:

Right breast mass, breast conservative surgery and axillary lymph node dissection specimens :

- Invasive duct carcinoma grade II.
- Free resected margins.
- Lymph nodes :Positive (7/21) with extracapsular extension.
- Stage : pT1c , pN2 .

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Sagda Elkady

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 03/11/2024 09:57:27

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / هدى شحات احمد عثريه :	Request No. : 13006941
Patient No. : 28202022102068	Request Date : 02/09/2024
Path No. : 3224/24	Verification Date : 08/10/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 42 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 1/09/2024.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: Her2 clone (4B5) & SISH.

Results:

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

- Her2: Moderate and complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).

-SISH: Not Amplified.

Average Her2 copy No. > (2.1), Her2/CEP17 ratio > (1.2)

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II.

IPT:

- Her2: Equivocal (score 2+) .

- SISH: Not Amplified.

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Sagda Elkady.

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 08/10/2024 10:59:54

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



Patient Name: Hoda Shahat Ahmed Abd Rabbo	Date : 24/09/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 3263/2024	Pat. ID: 79446

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

- Reported case of right breast cancer.

I Chest:

- *Right breast small parenchymal soft tissue lesion measures about 1.6 x 1.8 cm.*
- *Prominent ipsilateral axillary (level I & II) lymph nodes, the largest one seen at level I measures about 1.1 x 0.9 cm.*
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenuation. No sizable focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal non contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands.
- Under filled urinary bladder.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- No sizable worrisome osseous lesions.

Opinion:

- No sizable pulmonary, hepatic or osseous deposits on non-contrast basis.

Dr. Ali Elsisy, MSc.

Signature Prof. Menna Talla Hanafy

07/10/2024 07:40